

PSEUDOMIGRAÑA CON PLEOCITOSIS

Bocos Portillo Jone

INTRODUCCIÓN

La pseudomigraña con pleocitosis es una entidad poco frecuente caracterizada por episodios transitorios de déficits neurológicos, asociados a una cefalea de tipo migrañoso y un LCR con pleocitosis de predominio mononuclear.

Desde su descripción inicial en 1980 se ha usado diferente terminología para referirse a este cuadro clínico: “Síndrome migrañoso con pleocitosis en LCR”, “Pseudomigraña con pleocitosis”, “Síndrome de cefalea y déficit neurológico transitorio con pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo” (en inglés, Síndrome de HaNDL- Syndrome of transient Headache and Neurological Deficits with cerebrospinal fluid Lymphocytosis). En 2013 se publicó la 3ª edición de la clasificación internacional de las cefaleas, donde se le incluye dentro del apartado “Cefalea atribuida a enfermedad inflamatoria no infecciosa”

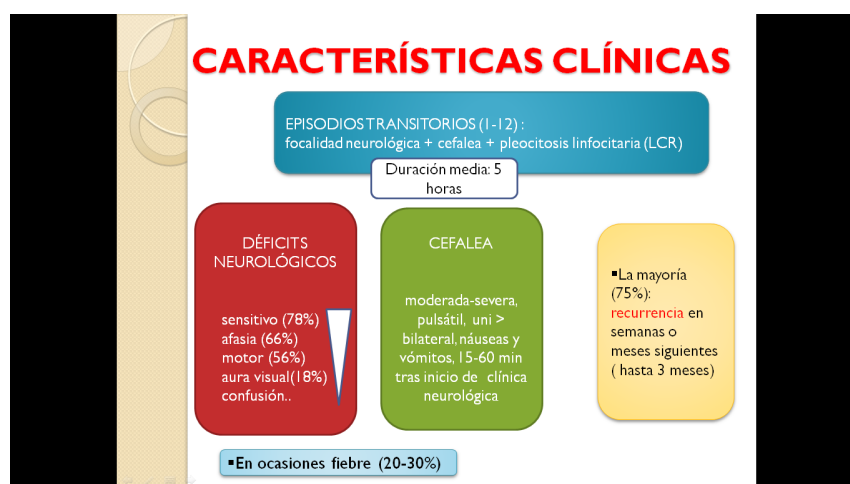
La etiopatogenia de esta entidad es desconocida. Se plantea la posibilidad de que se trate de una reacción a un factor infeccioso – inflamatorio previo que originara una respuesta inmune contra ciertos antígenos neurovasculares, dando lugar a una vasculitis leptomeningea, algo consistente con el LCR inflamatorio y con el frecuente antecedente de infección previa. Menos probable es que se trate de una migraña con aura grave, aunque las pruebas de neuroimagen funcional (perfusión-SPECT) serían consistentes. Otras hipótesis como la posibilidad de una canalopatía no han sido tan aplaudidas.

Es un síndrome poco frecuente. La incidencia se sitúa en torno a 1/1.000.000 habitantes. Es más habitual su aparición entre los 30-50 años, aunque se han descrito casos desde edades <10 años hasta >50, con práctica igualdad en cuanto al género (se ha descrito un ligero predominio de sexo masculino en alguna serie de casos). Son poco frecuentes los antecedentes personales y familiares de migraña. En alrededor del 25-40% de los casos existe en las semanas previas un antecedente de una viriasis (catarro común, diarrea...).

En cuanto a la presentación clínica (Figura 1), cursa con episodios transitorios de déficits neurológicos focales con una duración media de 5h, habiéndose descrito casos con duraciones variables entre escasos minutos y varios días (72 horas) . Entre los déficits neurológicos más frecuentes se encuentra la alteración sensitiva en primer lugar, seguido de la afasia y en 3º lugar la hemiparesia. Otros déficits tales como alteraciones visuales, síndrome confusional, etc., son menos frecuentes. Ocasionalmente puede asociarse fiebre.

A su vez, es imprescindible la presencia de una cefalea de perfil migrañoso moderada- severa, que suele presentarse paralelamente o, más frecuentemente, posterior al desarrollo del déficit focal.

Estos episodios son transitorios; por ello se considera una entidad benigna, si bien es cierto que en el 75% de los casos suele haber recurrencias en las semanas siguientes, principalmente dentro de los 3 primeros meses. Por ello, es importante recalcar este dato tanto al paciente como al entorno familiar y médico.



Características clínicas. Esquema

DIAGNÓSTICO

Se trata de un diagnóstico de exclusión.

La premisa fundamental es demostrar la presencia de pleocitosis en el LCR (10-700 leucocitos/ μ L), de predominio linfocitario. Existe una hiperproteínoorraquia en > 90% de los casos (20-250mg/dL) y una presión de apertura elevada en > 50%. Los estudios microbiológicos en LCR son negativos, así como también la autoinmunidad. La resolución de las alteraciones en LCR es lenta, pudiendo tardar hasta varios meses en normalizarse.

Los estudios de perfusión cerebral (p.ej., TC perfusión) realizados durante el episodio clínico pueden ser normales o mostrar una hipoperfusión focal o difusa en relación con el déficit y la RM cerebral suele ser normal o mostrar una leve captación leptomenínea. El **electroencefalograma** generalmente muestra anomalías, en forma de lentificación focal o difusa uni > bilateral. La angiografía cerebral suele ser normal y no se recomienda salvo alta sospecha de vasculitis, puesto que se ha llegado a considerar un precipitante. Otras pruebas funcionales como el SPECT cerebral pueden mostrar áreas focales o difusas de hipoperfusión (similar a lo que ocurre en la migraña hemipléjica).

Existen unos criterios diagnósticos propuestos por la ICHD-3 (International Classification of Headache Disorders).

- **A)** Episodio de cefalea de tipo migrañoso que cumple los criterios B y C
- **B)** Las dos características siguientes:
 - Se presenta junto con o de manera posterior al inicio de al menos uno de los déficits neurológicos transitorios siguientes, con una duración de más de 4 horas:
 - Hemiparestesia.
 - Disfasia.
 - Hemiparesia.
 - Se asocia a pleocitosis linfocitaria del LCR (>15 leucocitos por μ L), con estudios etiológicos negativos.
- **C)** La causalidad queda demostrada mediante uno o ambos de los siguientes:
 - La cefalea y los déficits neurológicos transitorios se desarrollan o empeoran significativamente en relación temporal con la pleocitosis linfocítica, o ha conducido a su diagnóstico.

- La cefalea y los déficits neurológicos transitorios han mejorado de manera significativa simultáneamente con la mejoría de la pleocitosis linfocítica del LCR.
- **D)** Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con ciertos cuadros clínicos, entre los que destacan: ictus, migraña con aura, meningoencefalitis, crisis epilépticas, vasculitis del SNC, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y el PRES.

De todos ellos, el ictus es sin duda la patología que inicialmente puede dificultar el diagnóstico de esta entidad en el servicio de Urgencias. Por ello, es importante un alto índice de sospecha, para poder llevar a cabo un correcto diagnóstico y evitar pruebas diagnósticas y tratamientos innecesarios.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La evolución de esta entidad es benigna, con resolución espontánea en un tiempo variable, pero con alta probabilidad de recurrencias en los primeros 3 meses. Hasta el momento actual, se han probado muchos fármacos de diferentes familias (antiepilépticos, corticoesteroides...), pero ningún fármaco ha demostrado ser efectivo en la prevención de estas recurrencias. El tratamiento, hoy por hoy, es sintomático, del dolor.

Lo fundamental es dar una información correcta y clara al paciente, familia y al entorno médico acerca de esta entidad y hacer hincapié en la posibilidad de recurrencias. Este hecho es muy importante en el servicio de Urgencias, puesto que es aquí a donde acudirán estos pacientes probablemente en muchas de las recurrencias. De tal modo, que conociendo esta información se pueden evitar pruebas diagnósticas innecesarias, como pueden ser las pruebas radiológicas repetidas.

PUNTOS DE ALERTA

- Paciente joven (30-50 años) sin antecedentes de interés con déficit neurológico + cefalea intensa + pleocitosis en LCR: pensar en el síndrome de HaNDL.
- Déficits neurológicos más frecuentes: hemihipoestesia, afasia y hemiparesia
- Es un diagnóstico de exclusión. Diagnóstico exhaustivo. "Stroke mimic"
- Manejo sintomático. Explicar recurrencias posteriores (¡hasta 3 meses desde el inicio!), para evitar pruebas diagnósticas innecesarias

BIBLIOGRAFÍA

- A Kerasnoudis, R Gold, M, Suk Yoon. Clinical Reasoning: A 48-year-old woman with recurrent headache, transient neurologic symptoms, and CSF pleocytosis. *Neurology* August 14, 2012 vol. 79 no. 7 e59-e62
- J. Barón, P. Mulero, M.I. Pedraza et al. Síndrome HaNDL: correlación entre la topografía del déficit neurológico y las alteraciones en electroencefalograma y SPECT en una serie de 5 nuevos casos. *Neurología* 2016;31:305-10
- III Edición de la clasificación internacional de cefaleas
- Cifelli A, Vaithianathar L. Syndrome of transient Headache and Neurological Deficits with cerebrospinal fluid Lymphocytosis (HaNDL). *BMJ Case Reports*. 2011;2011:bcr0320102862. doi:10.1136/bcr.03.2010.2862.